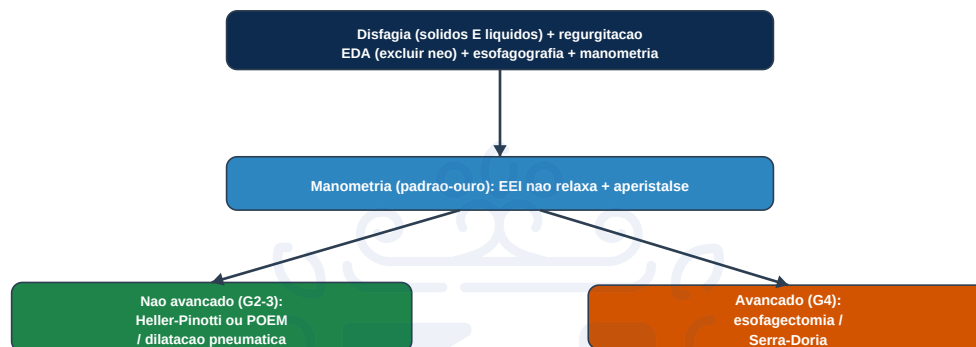


ACALÁSIA — DISFAGIA + MANOMETRIA

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

ACALÁSIA — DISFAGIA -> EDA + EED + MANOMETRIA



DEFINIÇÃO E ETIOLOGIA

PRINCIPAL DISTÚRPIO MOTOR DO ESÔFAGO

- Degeneração do plexo mioentérico (Auerbach) -> relaxamento INCOMPLETO do EEI + APERISTALSE do corpo esofágico
- No Brasil, megaesôfago CHAGÁSICO responde por ~90% (parasitismo neuronal, inflamação, autoimunidade)
- Outras causas: idiopática, genética, gás mostarda (lesão nervosa)
- Sintomas: DISFAGIA (para sólidos E líquidos), regurgitação, manobras (coluna d'água), globus, emagrecimento lento
- Escala de Eckardt gradua os sintomas (disfagia, regurgitação, dor, perda de peso)

EXAMES

Exame	Papel / achados
EDA	EXCLUIR neoplasia (pseudoacalásia); cromoscopia com lugol; ruim para diagnosticar acalásia
Esofagografia (EED)	Grau de dilatação (escolha do tratamento): 'bico de pássaro/cauda de rato', ondas terciárias, estase, ausência de bolha gástrica
Manometria (PADRÃO-OURO)	EEI com relaxamento incompleto + aperistalse; alta resolução: tipo I (sem pressurização), II (panesofágica), III (espástica)
Classificação	Rezende-Mascarenhas (graus I-IV pela dilatação) orienta a terapêutica

TRATAMENTO

Rx OPÇÕES POR RISCO/GRAU

Clínico (pouco usado): nitrato sublingual ou nifedipino — sintomas leves/alto risco cirúrgico; efeito colateral: hipotensão
Toxina botulínica no EEI: melhora TEMPORÁRIA (máx ~6 meses) — alto risco cirúrgico
Dilatação pneumática endoscópica: opção no alto risco cirúrgico; alta recidiva, ruim em jovens; risco de laceração
Cirúrgico PADRÃO-OURO (não avançado, G2-3): cardiomiectomia + funduplicatura (HELLER-PINOTTI), miotomia de 7-9 cm pegando o EEI
POEM (miotomia endoscópica peroral): eficaz; principal complicação é o REFLUXO (importante)
Avançado (G4/megaesôfago): esofagectomia com tubo gástrico; Thal-Hatafuku; Serra-Doria + vagotomia

RECIDIVA DA DISFAGIA E SEGUIMENTO

PONTOS DE ATENÇÃO

- Disfagia PRECOCE pós-op: miotomia curta/incompleta, migração aguda
- Disfagia TARDIA: fibrose da cárdia, reaproximação das bordas, refluxo intenso (estenose), megaesôfago avançado, NEOPLASIA
- Seguimento com EDA: risco aumentado de carcinoma espinocelular (CEC) de esôfago
- POEM tem alto índice de refluxo — vigiar e tratar (IBP)
- A acalásia é doença crônica: acompanhamento prolongado

MODELO DE REGULAÇÃO / ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA ENCAMINHAMENTO

- Paciente ____ anos com disfagia para sólidos e líquidos + regurgitação; Eckardt ____; sorologia para Chagas: ____.
- EDA (neoplasia excluída?) ____; EED: dilatação grau ____ (Rezende); manometria: ____.
- Conduta proposta: Heller-Pinotti / POEM / dilatação (alto risco) / esofagectomia (avançado).
- Encaminhamento à cirurgia do aparelho digestivo; manter seguimento por EDA (risco de CEC).

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é o exame padrão-ouro para o diagnóstico de acalásia?

- A) Endoscopia digestiva alta
- B) Manometria esofágica
- C) Esofagografia baritada
- D) Tomografia de tórax
- E) pHmetria

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é a principal causa de acalásia (megaesôfago) no Brasil?

- A) Idiopática
- B) Doença de Chagas (megaesôfago chagásico)
- C) Neoplásica
- D) Genética
- E) Pós-radioterapia

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual é o tratamento cirúrgico padrão-ouro da acalásia não avançada?

- A) Esofagectomia
- B) Cardiomiectomia a Heller com fundoplicatura (Heller-Pinotti)
- C) Gastrectomia total
- D) Vagotomia isolada
- E) Apenas dilatação pneumática

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual é a principal complicação do POEM (miotomia endoscópica peroral)?

- A) Hemorragia maciça
- B) Refluxo gastroesofágico
- C) Estenose pilórica
- D) Perfuração gástrica
- E) Pancreatite

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Por que o seguimento endoscópico é importante no paciente com acalásia/megaesôfago?

- A) Risco de úlcera duodenal
- B) Risco aumentado de carcinoma espinocelular (CEC) de esôfago
- C) Risco de adenoma gástrico
- D) Risco de varizes
- E) Risco de divertículo de Zenker

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A manometria esofágica é o padrão-ouro: demonstra relaxamento incompleto do EEI e aperistalse do corpo. A EDA exclui neoplasia e a esofagografia gradua a dilatação.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

No Brasil, ~90% dos megaesôfagos são chagásicos (doença de Chagas), por destruição do plexo mioentérico.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A cardiomiectomia a Heller com funduplicatura (Heller-Pinotti) é o padrão-ouro cirúrgico na acalásia não avançada (graus 2-3); a funduplicatura reduz o refluxo pós-miotomia.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O POEM é eficaz para a disfagia, mas tem como principal complicação o refluxo gastroesofágico (por não incluir funduplicatura), exigindo vigilância e IBP.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O megaesôfago mantém risco aumentado de carcinoma espinocelular de esôfago, justificando o seguimento endoscópico prolongado, mesmo após tratamento.

SM24
Suporte ao Plantão Médico